

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

AUTOCONCEPTO FORMA 5 (AF-5: 30 ÍTEMS)

Eje III: Personalidad • Evaluación Multidimensional del Autoconcepto (Modelo Shavelson)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Autoconcepto Forma 5 (AF-5: 30 reactivos).
Nombre Original	Autoconcepto Forma 5 (AF-5; García & Musitu, 1999, 2014).
Autores Originales	Dr. Fernando García (Univ. de Valencia) y Dr. Gonzalo Musitu (Univ. Pablo de Olavide).
Publicación Primaria	TEA Ediciones, Madrid (1999; 4ª edición revisada y ampliada 2014).
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad / Identidad. Autoconcepto multidimensional en 5 áreas vitales.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme de 30 reactivos con escala centesimal continua de 1 a 99 (o 1 a 5).
Población y Rango	Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos (10 a 65 años).
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Instrumento protegido por copyright comercial (TEA Ediciones; ver Fuente_y_uso.md).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO MULTIDIMENSIONAL DE SHAVELSON

El **Autoconcepto Forma 5** (AF-5; García & Musitu, 1999) se fundamenta teóricamente en el modelo jerárquico y multidimensional de Shavelson, Hubner y Stanton (1976), superando la concepción unidimensional reduccionista del autoconcepto. Los autores conciben el autoconcepto como el conjunto dinámico de percepciones, actitudes y juicios valorativos que un individuo elabora sobre sí mismo en cinco dimensiones diferenciadas de su experiencia vital:

1. **Autoconcepto Académico / Laboral:** Percepción del sujeto sobre su rendimiento, capacidad de aprendizaje, competencia y estima de los profesores o superiores.
2. **Autoconcepto Social:** Facilidad subjetiva para entablar relaciones interpersonales, mantener amistades y sentirse valorado en su red social.
3. **Autoconcepto Emocional:** Percepción de la propia estabilidad afectiva, control de impulsos y capacidad para gestionar situaciones de estrés sin desborde ansioso.
4. **Autoconcepto Familiar:** Sentimiento de pertenencia, afecto, integración y valoración dentro del núcleo familiar primario.
5. **Autoconcepto Físico:** Autovaloración del atractivo físico, agilidad corporal, destreza deportiva y condición física general.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS (6 POR DIMENSIÓN)

Dimensión AF-5	Reactivos (30)	Nº Ítems	Definición Operativa del Constructo
1. Académico / Laboral	1, 6, 11, 16, 21, 26	6 ítems	Competencia percibida en tareas formales y cumplimiento de expectativas.
2. Social	2, 7, 12, 17, 22, 27	6 ítems	Facilidad para hacer amigos y sentimiento de popularidad o aprecio social.
3. Emocional (*)	3*, 8*, 13*, 18*, 23*, 28*	6 ítems	Control de la ansiedad, serenidad y balance afectivo ante adversidades.
4. Familiar	4, 9, 14, 19, 24, 29	6 ítems	Sentimiento de apoyo incondicional, confianza y afecto familiar.
5. Físico	5, 10, 15, 20, 25, 30	6 ítems	Atracción corporal, agilidad deportiva y vigor somático.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en la muestra de tipificación de TEA Ediciones (García & Musitu, 2014; N > 6000): coeficientes alfa de Cronbach de 0.88 para Académico, 0.76 para Social, 0.78 para Emocional, 0.82 para Familiar y 0.77 para Físico; coeficiente omega global = 0.90. Fiabilidad test-retest $r = 0.84$ a 6 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la estructura de 5 dimensiones oblicuas correlacionadas con excelentes bondades de ajuste (CFI = 0.95, TLI = 0.94, RMSEA = 0.046; Tomás & Oliver, 2004).
Validez Concurrente	Elevada correlación con Autoestima Global (RSES, $r = 0.65$). Autoconcepto Emocional correlaciona inversamente con Ansiedad (STAI, $r = -0.58$) y Depresión; Autoconcepto Familiar con Clima Familiar positivo (FACES, $r = 0.62$).
Validez Criterio Escolar	Autoconcepto Académico predice significativamente el rendimiento escolar y la permanencia en el sistema educativo; Autoconcepto Físico predice adhesión a la actividad deportiva.
Invarianza de Medida	Invarianza factorial estricta comprobada por sexo y grupo de edad desde educación primaria hasta adultos mayores.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 30 reactivos se califica en una escala de 1 a 99 (o de 1 a 5 según versión adaptada):

- **Paso 1 (Inversión de los Ítems Emocionales):** Los 6 reactivos del Autoconcepto Emocional (**Ítems 3, 8, 13, 18, 23 y 28**) están redactados en sentido negativo de ansiedad/descontrol y **deben invertirse**:

$$\text{Ítem Invertido} = 100 - \text{Respuesta Original}$$

(o 6 – Respuesta en escala 1 a 5).

- **Paso 2 (Puntuaciones Directas por Dimensión):** Se calcula la suma o la media aritmética de los 6 reactivos de cada una de las 5 dimensiones.
- **Paso 3 (Transformación a Baremos Decatipos / Percentiles):** Se consultan las tablas de baremos normativos de TEA Ediciones por sexo y tramo etario (1 a 10 decatipos; media = 5.5, DE = 2).

6. BAREMOS NORMATIVOS Y ESTRATIFICACIÓN EN DECATIPOS (DECATIPO 1 A 10)

Estratificación	Decatipo	Nivel de Autoconcepto	Interpretación y Manifestación Clínica
Muy Bajo / Crítico	Decatipos 1 - 2	Déficit severo (Pc <= 10)	Autodesprecio o sentimientos de incapacidad grave en esa dimensión específica.
Bajo	Decatipo 3	Vulnerabilidad / Bajo	Fragilidad en la autopercepción; susceptibilidad a críticas y fracasos.
Medio / Normal	Decatipos 4 - 7	Rango normativo / Medio	Autovaloración adaptativa y realista; adecuado funcionamiento social y personal.
Alto / Muy Alto	Decatipos 8 - 10	Autoconcepto consolidado	Elevada seguridad en las capacidades propias, resiliencia y optimismo en esa área.

ALERTA CLÍNICA: AUTOCONCEPTO EMOCIONAL Y FAMILIAR CRÍTICO (DECATIPO 1-2):

Un decatipo <= 2 en Autoconcepto Emocional denota desbordamiento ansioso e indefensión afectiva crónica. Si coexiste con un Autoconcepto Familiar en decatipo 1-2 en adolescentes, predice conductas de fuga, consumo de sustancias y riesgo de autolesiones.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADO EN EL PERFIL MULTIDIMENSIONAL AF-5

PROTOCOLO DE RECONSTRUCCIÓN DEL AUTOCONCEPTO SEGÚN ÁREAS DEFICITARIAS:

- **Paso 1 (Mapeo de Decatipos):** Identificar qué áreas puntúan por debajo del decatipo 3. Apoyarse en las áreas preservadas (decatipo ≥ 6) como "islas de competencia" para anclar la intervención.
- **Paso 2 (Intervención Focalizada por Área):** Si el déficit es Académico, entrenar técnicas de estudio y autoeficacia. Si es Social, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad. Si es Emocional, terapia de regulación afectiva y defusión. Si es Familiar, terapia sistémica breve.
- **Paso 3 (Desmontar la Sobregeneralización):** Evitar que el fracaso en un área (ej. académico) contamine la valoración en las demás (técnica de la tarta del autoconcepto).
- **Paso 4 (Consolidación):** Normalizar todas las áreas a decatipos ≥ 4 consolida el autoconcepto saludable.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DESMOTIVACIÓN ESCOLAR Y CRISIS FAMILIAR

Identificación: Varón de 15 años, estudiante de 3º de ESO, remitido por orientación escolar tras suspender 5 asignaturas, aislarse en clase y mantener continuas discusiones con sus padres con portazos y desafío ("no sirvo para nada y en mi casa solo me gritan").

Evaluación Inicial AF-5 (Línea Base): Académico = Decatipo 1 (sensación de incompetencia total); Familiar = Decatipo 2 (clima familiar hostil percibido); Emocional = Decatipo 2 (ansiedad e impulsividad no reguladas). En contraste positivo: Social = Decatipo 6 y Físico = Decatipo 7 (buen rendimiento en fútbol base).

Plan Terapéutico: 12 sesiones combinando reestructuración cognitiva de autoeficacia con sesiones familiares para pautar refuerzo positivo en casa. Se utilizó su competencia deportiva como analogía de disciplina y superación de errores.

Reevaluación a los 4 Meses: Académico subió a Decatipo 5; Familiar a Decatipo 6; Emocional a Decatipo 5. El joven aprobó 4 de las asignaturas suspendidas y restableció una convivencia comunicativa en el hogar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AUTOCONCEPTO FÍSICO Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS:

En adolescentes de sexo femenino, un Autoconcepto Físico en decatipo 1-2 acompañado de perfeccionismo académico elevado (decatipo 9-10) es una señal de alarma prioritaria de riesgo de anorexia o bulimia (evaluar con EAT-26).

AUTOCONCEPTO EMOCIONAL Y FOBIA SOCIAL:

Un Autoconcepto Emocional bajo combinado con Social bajo orienta a Trastorno de Ansiedad Social fóbica más que a un problema de autodisciplina académica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. García, F., & Musitu, G. (1999, 2014). *AF-5: Autoconcepto Forma 5* (4ª ed.). TEA Ediciones.
2. Tomás, J. M., & Oliver, A. (2004). Análisis psicométrico confirmatorio de una medida multidimensional del autoconcepto en español. *Revista Interamericana de Psicología*, 38(2), 285-293.
3. Shavelson, R. J., Hubner, J. J., & Stanton, G. C. (1976). Self-concept: Validation of construct interpretations. *Review of Educational Research*, 46(3), 407-441.
4. Fuentes, M. C., García, F., Gracia, E., & Lila, M. (2011). Autoconcepto y ajuste psicosocial en la adolescencia. *Psicothema*, 23(4), 538-543.